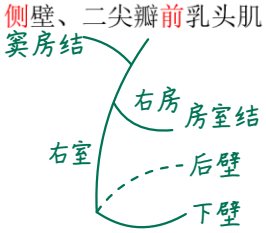
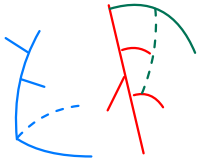
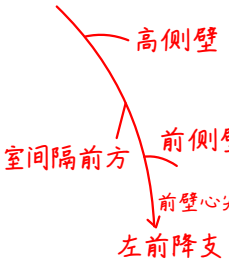
左前降支：左室前壁心尖、前间壁、侧壁、二尖瓣前乳头肌
“前侧”



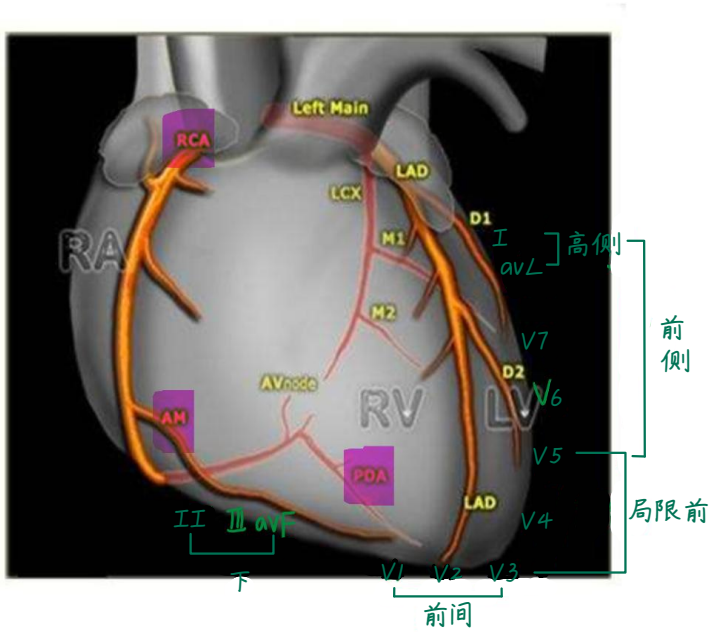




左回旋支：左室侧壁、左房

右冠脉：右房、右室、左室下壁/膈面（右冠脉优势型）、后壁（右冠脉优势型）、窦房结、房室结

- 左冠状动脉主干（LM）
  - 左前降支（LAD）
    - ✓对角支（D）
    - ✓间隔支（S）
  - 回旋支（LCX）
    - ✓钝缘支（OM）
- 右冠状动脉（RCA）
  - 圆锥支
  - 窦房结支
  - 右室支
  - 锐缘支（AM）
  - 房室结支
  - 后降支（PDA）



II、III、aVF→下壁→右冠脉
V1V2V3→前间壁→左前降支

表 3-4-4　ST 段抬高型心肌梗死的心电图定位诊断

导联	前间隔	局限前壁	前侧壁	广泛前壁	下壁[①]	下间壁	下侧壁	高侧壁[②]	正后壁[③]
V_1	+			+		+			
V_2	+			+		+			
V_3	+	+		+		+			
V_4		+		+					
V_5		+	+	+			+		
V_6			+				+		
V_7			+				+		+
V_8									+
aVR									
aVL		±	+	±	−	−	−	+	
aVF					+	+	+	−	
I		±	+	±	−	−	−	+	
II					+	+	+	−	
III					+	+	+	−	

注：①即膈面。右心室 MI 不易从心电图得到诊断，但 CR_{4R}（负极置于右上肢前臂，正极置于 V_4 部位）或 V_{4R} 导联的 ST 段抬高，可作为下壁 MI 扩展到右心室的参考指标。②在 V_5、V_6、V_7 导联高 1～2 肋处可能有改变。③在 V_1、V_2、V_3 导联 R 波增高。同理，在前侧壁梗死时，V_1、V_2 导联 R 波也增高。“+”为正面改变，表示典型 ST 段抬高、Q 波及 T 波变化；“−”为反面改变，表示 QRS 波群主波向上，ST 段压低及与“+”部位的 T 波方向相反的 T 波；“±”为可能有正面改变。